

恩主公醫院

健康檢查報告

姓 名：王來賓
性 別：女
生 日：1985/02/14
身分證字號：F222222222
健 檢 編 號：0009876543
健 檢 套 裝：114 年鴻齡科技/新加坡鴻運科公司健檢套餐
-防癌 A-35000-(女)
健 檢 日 期：2025/03/25
報 告 醫 師：劉顯達 醫師

目 錄

診斷及建議	4
主訴與病史	8
系統體格檢查表	8
理學檢查	9
眼科檢查	10
純音聽力會診	12
靜態心電圖	14
肺功能	15
心律變異率檢查	16
婦科會診	17
身體組成分析	18
實驗室檢查	19
精密儀器檢查	23

內視鏡檢查	31
中醫十二經絡	40
十年心血管疾病風險	40

診斷及建議 (**Diagnosis and Suggestion**)

器官顯著異常問題，立即門診診斷與治療無

個別器官異常問題，門診追蹤治療

1. 抗核抗體呈陽性：此項檢查對全身性紅斑性狼瘡有高敏感性(98%)，但專一性較低。
陽性反應也出現於 30-50%其他的自體免疫疾病如硬皮症(scleroderma)、修格蘭(Sjogren)症候群、全身性硬化症、多發性肌炎／皮肌炎、血管炎症候群、類風溼性關節炎(RA)等，建議至風濕免疫科門診進一步追蹤。
2. 甲狀腺超音波檢查報告為(1)右側甲狀腺囊腫 0.37 公分併鈣化(2)左側甲狀腺囊腫 0.29 公分、0.44 公分及 0.54 公分併鈣化：血液甲狀腺功能檢查正常，請每年至新陳代謝科或家庭醫學科門診追蹤檢查。如有持續增長、快速腫大、不對稱腫大或觸摸到腫瘤等，則應提早及進一步評估治療。如您已經有在固定的門診追蹤，請遵循原主治醫師的建議。
3. 腹部超音波檢查報告為極輕度脂肪肝：表示肝細胞脂肪含量過多，常見的原因有肥胖、飲酒過量、血脂肪過高、糖尿病、肝炎、服用某些藥物等，建議您維持理想體重，改採健康的生活方式，控制飲酒量，並定期追蹤肝功能及腹部超音波檢查。
4. 腹部超音波檢查報告為肝臟結節 0.75 公分，疑似血管瘤：血管瘤為肝臟內血管不正常增生所形成的腫瘤，是肝臟最常見的良性腫瘤，通常不會有症狀，但在超音波下有時和肝癌不容易區別，若為第一次發現，請三到六個月內至家庭醫學科或胃腸肝膽科門診追蹤檢查，若已知且無變化，請每年至家庭醫學科或胃腸肝膽科門診追蹤檢查。
5. 心臟超音波檢查報告為輕度三尖瓣閉鎖不全輕度肺動脈瓣閉鎖不全：常見的原因有瓣膜結構異常、心房心室擴大、心肌病變、高血壓性心臟病、風濕性心臟病等，建議您健康低脂飲食，減少鹽分的攝取，避免高血壓，維持理想體重，養成每天規律運動的好習慣，並定期至心臟血管科門診追蹤檢查。
6. 胃鏡檢查報告為輕度至中度逆流性食道炎(LA class B)：逆流性食道炎是指胃的酸性內容物逆流而導致食道黏膜組織發炎或破損，依照胃鏡檢查食道黏膜受損的嚴重程度，由輕到重分為 A、B、C、D 四級。長期胃液逆流可能導致食道糜爛、潰瘍、黏膜上皮改變等，發生食道腺癌的危險性增加，建議您調整飲食與生活型態，適量進食，避免咖啡、濃茶、碳酸及酒精性飲料，避免辛辣刺激、高熱量、高糖及高油脂食物，避免用餐後立刻躺下，睡前勿進食，睡覺時墊高頭頸部，戒菸減重多運動，少穿緊身衣褲。如有咽部灼燒感、火燒心、胃酸逆流、噯氣、打嗝等症狀，則應至家庭醫學科或胃腸肝膽科門診進一步評估治療。
7. 鼻咽喉內視鏡檢查報告為(1)兩側鼻中膈彎曲(2)慢性肥厚性鼻炎(3)急性咽喉炎：建議您增加水份攝取，避免發聲過度或使用不當，減少菸酒刺激，休息觀察。如有發

燒、持續疼痛、聲音嘶啞等症狀，則應至耳鼻喉科門診進一步評估治療。

器官輕微變化，如有相關症狀，請至門診複查

1. 有高血壓、糖尿病家族史：請定期監測血糖、血壓。
2. 有癌症家族史：請定期接受身體健康檢查。
3. (1)體重過重(2)體質指數過重(3)體脂率偏高且腹圍超標：肥胖與心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、高膽固醇血症、睡眠呼吸中止症、癌症等疾病相關，建議您攝取均衡營養，維持規律活動，選擇中等強度全身有氧運動與肌肉耐力運動，搭配重量訓練增加肌肉量以提高基礎代謝率，補充足夠水分，減去多餘體脂肪，維持體態標準。
4. 近視：建議您加強視力保健，減少長時間近距離用眼，避免眯眼視物及過度揉眼，防止近視度數惡化。
5. 靜態心電圖檢查報告為竇性不整脈、竇性心律：如有胸悶、頭暈、心悸、呼吸困難等症狀，則應至家庭醫學科或心臟內科門診進一步檢查評估，排除其他可能病因。
6. 丙型麩胺酸轉移酶(r-GT)偏低：通常無明顯臨床意義。
7. 肌酸酐偏低、腎絲球過濾率偏高：腎功能應無大礙，宜進行規律運動包含肌力訓練，以增加肌肉組成。
8. 乳酸脫氫酶(LDH)偏低：通常無明顯臨床意義。
9. B 型肝炎表面抗原呈陰性、B 型肝炎表面抗體呈陽性：代表您對 B 型肝炎有抵抗力，不用注射疫苗。
10. C 型肝炎抗體呈陰性：代表您沒有感染 C 型肝炎。
11. 尿液酮體呈陽性：正常尿液中不含有酮體，常見異常的原因有空腹時間過長、減重(限制澱粉類食物)、糖尿病等。如血糖、尿糖異常或有持續不明症狀，則應至家庭醫學科或代謝內分泌科門診進一步檢查評估。
12. 尿液酸鹼度異常、尿潛血呈邊緣性反應併尿中紅血球偏多、尿液中細菌及上皮細胞過多：建議您平時多喝水，定時排尿，勿憋尿。如有發燒、急尿頻尿、解尿疼痛、血尿等症狀，建議您至家庭醫學科、泌尿科或感染科門診進一步評估治療。
13. 腹部超音波檢查報告為疑似副脾 1.03 公分：脾臟是人體最大的淋巴器官，位於左上腹部，約有 10%的人在脾門附近可發現一個與脾臟同質性回音的結節，常見大小約 1-3 公分，多為檢查時偶然發現，通常沒有臨床意義，建議您定期至胃腸肝膽科門診追蹤檢查。
14. 中醫十二經絡檢查報告：請詳見該頁診斷、養生建議及總表分析。
15. 十年心血管疾病風險評估屬於低度風險：正常健康族群的冠狀動脈疾病發生率隨年齡增加而升高，一次預測屬性為低度風險，不代表未來十年內不會發生心血管疾病。同理，原預測屬於高度風險者，透過危險因子的控制與改善，能降低未來罹患心血管疾病的風險值。因此，建議您針對個別的危險因子，採取適當的健康管理措施，維持良好的飲食生活習慣，預防心血管疾病。

16. 葉酸檢測分析結果為 677TT/1298AA：表示 MTHFR 基因帶有雙變異，葉酸代謝的效率會降低。葉酸是水溶性維生素 B9，可幫助紅血球及核酸與核蛋白形成、促進循環及健康維持、胎兒的正常發育與生長所需。因人體無法自行合成，必須仰賴充足的飲食營養攝取來補充，當 MTHFR 基因帶有雙變異時，將影響人體吸收葉酸的能力，使血液中的同半胱胺酸（Homocysteine）濃度提高，使成人罹患心血管疾病、巨球性貧血的風險提高；對孕婦而言，則會影響胎兒神經管發育。詳情請見附件說明。

主訴與病史 (Chief Complaint and Medical History)

此次安排健康檢查原因

1. 原因：定期檢查

生活習慣

1. 過去一個月內是否有吸菸？：從未吸菸
2. 過去六個月內是否有嚼食檳榔？：從未嚼食
3. 過去一個月內是否有喝酒？：偶爾喝(不是天天)

用藥史, 藥物過敏史, 病史及手術病史

1. 您是否有經過醫師確診之疾病？：氣喘、子宮肌瘤
2. 您是否曾動過外科手術？：(2024 年，子宮肌瘤微創)、(2019 年，植牙)
3. 您是否對藥物過敏？：否
4. 您是否對食物過敏？：否
5. 您是否有在使用藥物？：中藥感冒藥
6. 您目前是否有特殊治療情況？：無
7. 女性相關問題？：懷孕(否)、月經週期(規則)、經血量(正常)

家族史

1. 高血壓：祖父母
2. 心血管疾病：祖父母
3. 糖尿病：祖父母
4. 逆流性食道炎：母
5. 大腸(直腸)癌：父

系統體格檢查表 (Physical Examination)

項目	結果	參考值
身高 (Body height)	165.9 公分	

體重 (Body weight)	68.9 公斤	49.1 至 66.5 公斤
理想體重範圍公式： 男性：[(身高-80)*0.7] ± 10 % 女性：[(身高-70)*0.6] ± 10 %		
體質量指數 (BMI)	25.0	國人標準：18.5-23.9
腹圍 (Abdominal girth)	85 公分	國人女性標準：小於 80 公分
脈搏 (Pulse rate)	78 次/分鐘	60-100 次/分鐘
血壓 (Blood pressure)	114/68 mmHg	120-90 / 80-60 mmHg
音叉	正常	

理學檢查 (Physical Examination)

項目	結果
頭 (Head)	無明顯異常
眼 (Eye)	無明顯異常
頸 (Neck)	無明顯異常
甲狀腺 (Thyroid)	無明顯異常
淋巴結 (Lymph node)	無明顯異常
胸 (Chest)	無明顯異常
心 (Heart)	無明顯異常
肺 (Lung)	無明顯異常
腹 (Abdomen)	無明顯異常
背 (Back)	無明顯異常

四肢 (Extremities)	無明顯異常
週邊血管 (Peripheral vessels)	無明顯異常
皮膚 (Skin)	無明顯異常
其他 (Others)	無明顯異常
建議 (Suggestion)	無明顯異常

各科檢查(Inspection)

眼科檢查

	視力裸視	矯正視力	眼壓(<21)	電腦驗光	散光	辨色力
右眼	---	0.9	13	-2.25	-0.25	無異常
左眼	---	1.2	9	+0.00	-0.25	

免散瞳眼底攝影報告及影像



眼底攝影報告雙眼無明顯視神經及視網膜病變

診斷 (Diagnosis) 視力(Visual

acuity)：近視眼壓(Intraocular

pressure)：正常範圍

眼底(Fundus)：無明顯異常視網膜病變(Retinopathy)：無明顯異常

黃斑(Macula)：無明顯異常

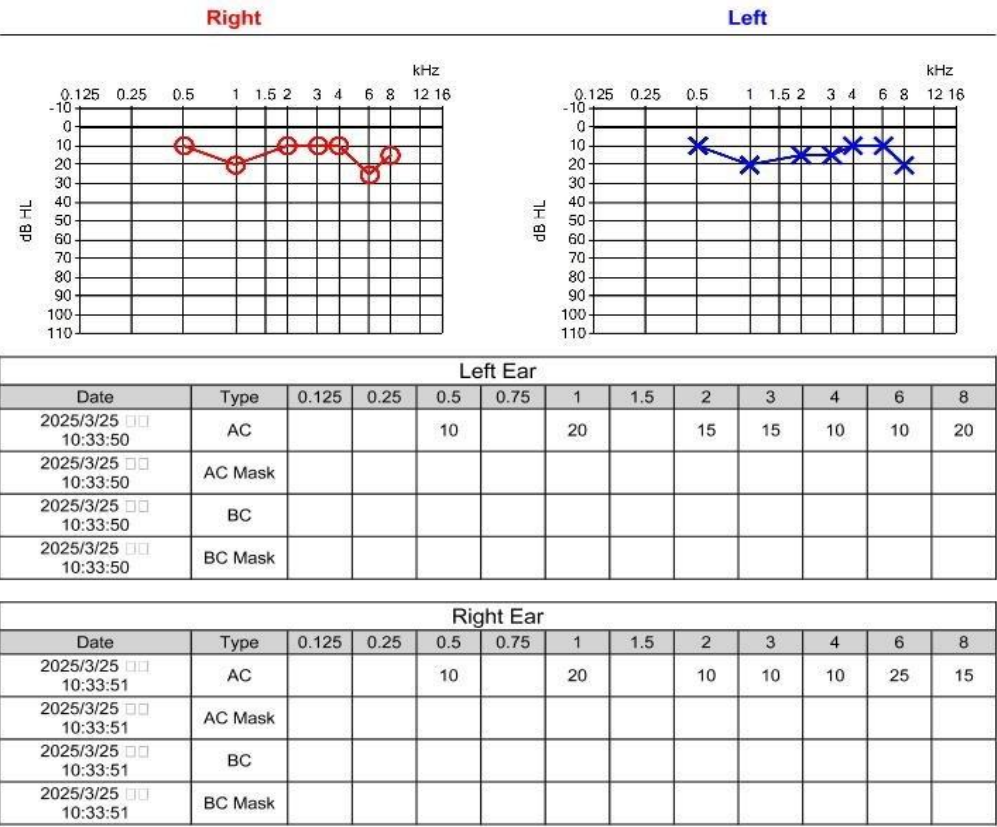
建議 (Suggestion)

定期門診追蹤

各科檢查(Inspection)

純音聽力會診

Patient ID: _____
Patient Name: _____
Date of Birth: _____
Gender: _____
Examiner/Signature: _____



全頻聽力							
	500 赫茲	1000 赫茲	2000 赫茲	3000 赫茲	4000 赫茲	6000 赫茲	8000 赫茲
右耳	10	20	10	10	10	25	15
左耳	10	20	15	15	10	10	20
診斷（ Diagnosis ）							
聽力正常							

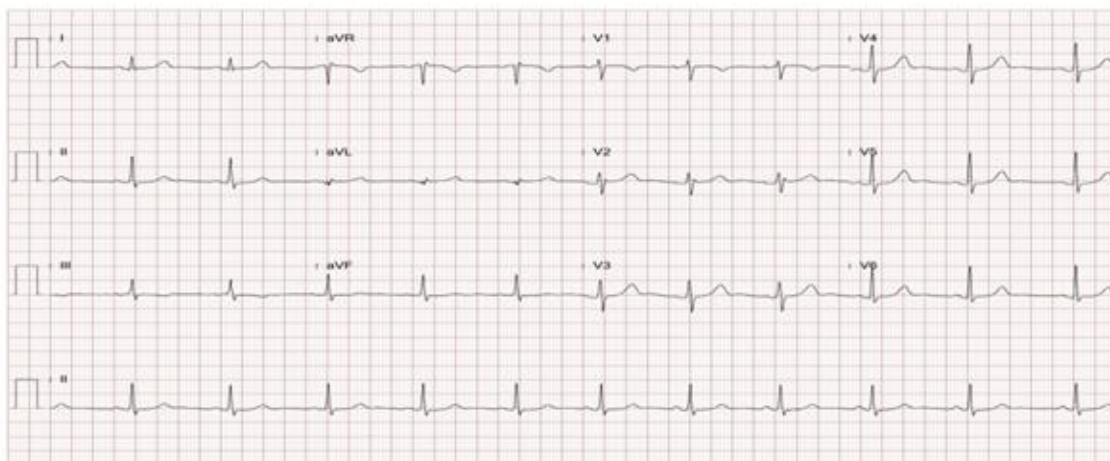
各科檢查(Inspection)

靜態心電圖

Patient ID: 001
Order Number: PEH143246003
Age: 40 Years
Sex: F
Name:
Comment:

2025/03/25 08:14:57
Vent rate: 67 BPM
PR int: 140 ms
QRS dur: 90 ms
QT/QTc: 406 / 422 ms
P-R-T axes: 47 60 13

9110 " normal ECG "
1100 Sinus rhythm
1102 Sinus arrhythmia
Reviewed By: S1018
Date: 2025/03/25 09:40:09



診斷 (Diagnosis)

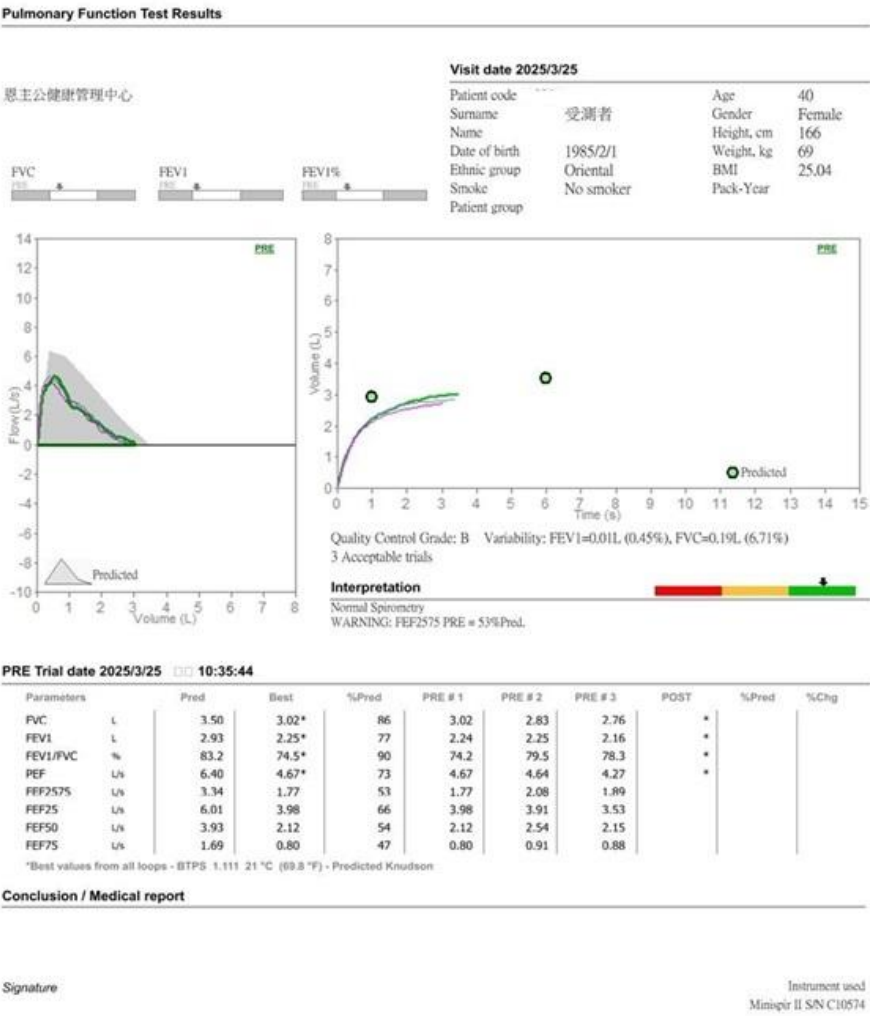
竇性不整脈、竇性心律

各科檢查(Inspection)

肺功能

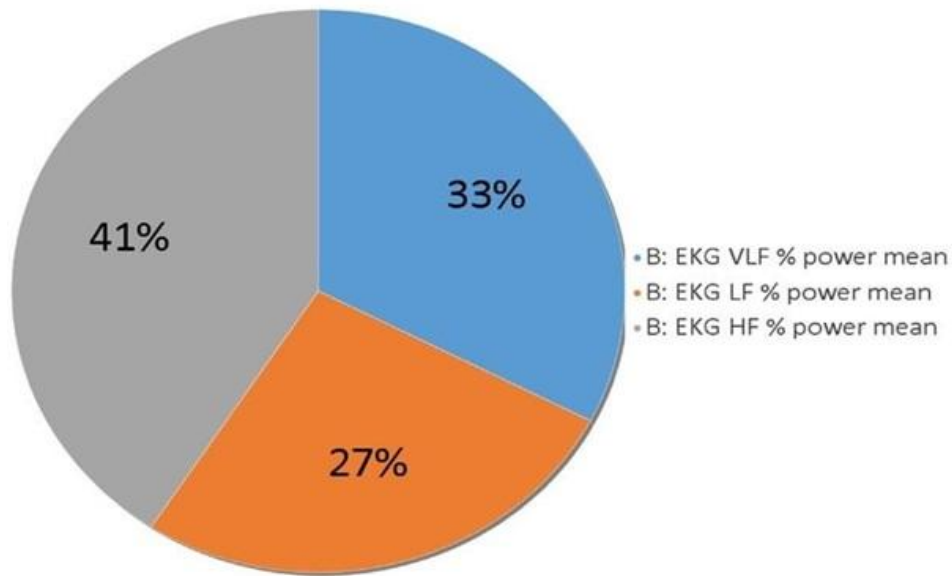
肺功能

診斷 (Diagnosis) 正常



心律變異率檢查

自律神經檢測報告 HRV- Heart Rate Variability Report			
基本資料(請先核對基本資料・若有訛誤請告知檢查人員)			
姓名：000	性別：女	檢查日期：	2025/03/25
出生日期：1985/2/1	身分證字號：F2		
檢測數據			
項目	檢測數值(單位)	標準範圍	
心跳速度(Heart Rate)	71.661	60~100(次/分鐘)	
自律神經偏向(Balance)	0.841		
自律神經總體功能(ANS)	26.107	>50%	
交感神經功能(SYM)	32.091		
副交感神經功能(VAG)	40.155		
RSA呼吸心跳變異數	4.419	7-10次/min	
NN間距標準差(SDNN)	33.0	31.03(ms)	
自律神經分布圖			



心律變異率檢查

各科檢查(Inspection)

診斷 (**Diagnosis**) 心律變異性正常

建議 (**Suggestion**)

健康狀況：心律變異性屬於正常範圍，應好好保持。自律神經功能偏向副交感，對週遭事物提不起勁，會呈現有些慵懶的感覺，也容易感到疲勞，還會有血壓偏低、記憶力變差的狀況，除此之外，身體有不耐冷熱的現象。

健康建議：

飲食方面：多補充富含維生素 B 及 C 與鈣質，能維持神經系統健康與穩定情緒。

運動方面：可以從事重量訓練與跑步等較激烈的運動，刺激交感神經活性，促使心跳加速、呼吸變快與排汗量增加。

生活方面：培養良好生活作息，維持充足的睡眠。

健康監控：定期監控 HRV 的數值，了解身體目前的狀態，若是 $BMI \geq 24$ ，則需要注意體重的監控，避免體重過重。

婦科會診

子宮頸抹片檢查及人類乳突病毒檢測結果如下：

薄層抹片細胞病理報告新柏氏抹片檢查：細胞正常

人類乳突病毒檢測結果：陰性診斷 (**Diagnosis**)

內診及外生殖器：無明顯異常

建議 (**Suggestion**) 定期子宮頸抹片檢查

實驗室檢查 (Laboratory Examination)

檢查項目	本次	前次	本次參考值
血液檢查 (Blood Cell Exam)			
紅血球.(RBC(B))	4.39	---	4-5.2 $10^6/\mu\text{L}$
白血球(WBC(B))	5.9	---	3.5-11 $10^3/\mu\text{L}$
血色素(Hb)	13.3	---	12-16 g/dL
血球比容積 (Ht)	39.3	---	36-46 %
血小板(Platelet)	363	---	150-400 $10^3/\mu\text{L}$
平均紅血球色素量(MCH)	30.3	---	26-34 pg
平均紅血球色素濃度(MCHC)	33.9	---	31-37 g/dL
平均紅血球容積(MCV)	89.5	---	80-100 fL
嗜中性顆粒球(Neutrophil)	63.6	---	41-72 %
淋巴球(Lymphocyte)	27.2	---	19-47 %
單核球(Monocyte)	5.3	---	4-11 %
嗜伊紅顆粒球(Eosinophils)	3.2	---	0-8 %
嗜鹼性顆粒球(Basophils)	0.7	---	0-2 %
有核紅血球(NRBC)	0.0	---	0-0.4 /100WBC
生化檢查 (Biochemistry Exam)			
白蛋白(Albumin)	4.2	---	3.5-5.7 g/dL
總蛋白(Total protein)	7.4	---	6.4-8.9 g/dL
鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase)	42	---	34-104 IU/L
肝功能檢查 (Liver Function)			
總膽紅素(Total Bilirubin)	0.79	---	0.26-1.22 mg/dL

直接膽紅素(Direct Bilirubin)	0.15	---	0-0.4 mg/dL
麩胺酸草醋酸轉氨基酶(AST)	14	---	0-40 IU/L
麩胺酸草丙酸轉氨基酶(ALT)	8	---	0-40 IU/L
丙型麩胺酸轉移酶(r-GT)	8	---	9-64 IU/L
腎功能檢查 (Renal Function)			
尿素氮(BUN)	7	---	7-25 mg/dL
肌酸酐(Creatinine)	0.50	---	0.6-1.2 mg/dL

檢查項目	本次	前次	本次參考值
腎絲球過濾率(eGFR)	145.24	---	90-125
血脂肪檢查 (Lipid)			
總膽固醇(Total Cholesterol)	162	---	<200 mg/dL
三酸甘油酯(Triglyceride TG)	78	---	<150 mg/dL
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)	51	---	男>40；女>50 mg/dL
低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)	102	---	<130 mg/dL
糖尿病檢查 (Plasma Glucose)			
飯前血糖(Glucose AC)	95	---	70-100 mg/dL
糖化血色素(HbA1c)	5.3	---	0-5.6 %
痛風檢查 (Gout)			
尿酸(Uric acid)	5.6	---	2.3-6.6 mg/dL
胰臟功能檢查 (Pancrease Function)			
胰臟澱粉酶(Amylase)	37	---	29-103 U/L
心臟血管功能檢查 (Cardiovascular Enzym Exam)			
高敏感度 C 反應蛋白(hs-CRP)	0.097	---	0-0.099 MG/DL
乳酸脫氫酶(LDH)	113	---	140-271 IU/L
肌酸磷化酶(CPK)	47	---	30-223 IU/L

甲狀腺檢查 (Thyroid Function)			
游離甲狀腺素免疫分析(Free T4)	0.74	---	0.59-1.43 NG/DL
甲狀腺刺激素免疫分析(TSH)	2.034	---	0.38-5.33 mIU/L
肝炎標記 (Hepatitis)			
B 型肝炎表面抗原(HBs-Ag)	Nonreactive(0.644)	---	Non-reactive(COI<0.9) ; Reactive(COI $\geq$ 0.9)
B 型肝炎表面抗體(Anti-HBs)	Reactive(101)	---	Non-reactive(<10 IU/L) ; Reactive($\geq$ 10 IU/L)
C 型肝炎抗體(Anti-HCV)	Nonreactive(0.0443)	---	Non-reactive(COI<0.9) ; Reactive(COI $\geq$ 0.9)
血液腫瘤標誌 (Tumor Markers)			
胎兒蛋白_肝癌指標 (Alpha-Fetoprotein)	3.1	---	<20 ng/mL
癌胚胎抗原(CEA)	2.7	---	不抽菸:<5.0 ; 抽 菸:<10.0 ng/mL
檢查項目	本次	前次	本次參考值
卵巢癌(CA-125)	21	---	$\leq$ 35 U/mL
乳癌(CA-153)	5.6	---	$\leq$ 23.5 U/mL
胰臟癌(CA-199)	7	---	$\leq$ 35 U/mL
其它檢查 (Others)			
抗核抗體(ANA (IFA))	Positive1:40 ; Speckled	---	NEGATIVE
尿液檢查 (Urine Routine)			
尿液顏色(Urine Color)	Amber	---	Yellow
尿液濁度(Clarity)	-	---	NEGATIVE
尿液酸鹼度(pH)	8.5	---	5-8
尿蛋白(Protein)	15	---	<30 mg/dL
尿糖(Glucose)	< 50	---	0-49
尿酮體(Ketone)	1+	---	NEGATIVE

尿比重(Specific gravity)	1.022	---	1.003-1.035
尿膽紅素(Bilirubin)	-	---	NEGATIVE
尿潛血(Occult Blood)	+/-	---	NEGATIVE
尿膽素原(Urobilinogen)	≤ 1.5	---	≤ 1.5 MG/DL
尿中亞硝酸鹽(Nitrite)	-	---	NEGATIVE
尿中白血球酯解酶(Leukocyte)	-	---	NEGATIVE
尿中細菌(Bacteria)	2+	---	NOT FOUND /HPF
尿中柱狀細胞(Cast)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中結晶體(Crystal)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中上皮細胞(Epithelial Cell)	6-9	---	0-5 /HPF
尿中黴菌(Fungi)	-	---	NOT FOUND
尿中黏液(Mucus)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中紅血球(R.B.C.)	6-9	---	0-2 /HPF
尿中滴蟲(Trichomonas)	-	---	NOT FOUND
尿中白血球(W.B.C.)	0-5	---	0-5 /HPF
其他(Other)	0.0	---	無

精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

頸動脈超音波檢查

報告
診斷（ Diagnosis ） 頸動脈：無明顯異常椎動脈：無明顯異常

精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

甲狀腺超音波檢查

報告
診斷（ Diagnosis ） 右側甲狀腺囊腫 0.37 公分併鈣化 左側甲狀腺囊腫 0.29 公分、0.44 公分及 0.54 公分併鈣化 建議（ Suggestion ） 建議每年至新陳代謝科或家庭醫學科門診追蹤檢查

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

腹部超音波

報告
診斷 (Diagnosis) 極輕度脂肪肝 肝臟結節 0.75 公分，疑似血管瘤疑似副脾 1.03 公分 膽胰腎：無明顯異常

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

心臟超音波檢查

報告
診斷 (Diagnosis) 左心房及左心室大小正常 左心室收縮功能正常(LVEF=75%) 輕度三尖瓣閉鎖不全 輕度肺動脈瓣閉鎖不全 無局部左心室壁活動異常

精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

乳房超音波檢查

報告
診斷（ Diagnosis ） 無明顯異常 乳房影像診斷分級（BI-RADS category）1

精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

婦科超音波檢查

報告
診斷（ Diagnosis ） 無明顯異常

精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

肝纖維化掃描

報告

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

診斷 (**Diagnosis**)

肝纖維化等級：正常 脂肪肝等級：正常

超音波影像



恩主公醫院

神經科頸動脈超音波檢查報告

病患姓名:	性別: F	檢查日期: 20250325
病歷號碼:	病患來源:	檢查時間: 101650
年齡: 40	病牀號碼:	編號: PEH06143246003

頸動脈超音波檢查

Right

Intima 0.61 mm

CCA Normal

BULB Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal



Left

Intima 0.59 mm

CCA Normal

BULB Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal



Flow Pattern 頸動脈生圖檢查

	PSV	EDV	RI		PSV	EDV	RI
CCA	97.3 cm/sec	28.2 cm/sec	0.71	CCA	134.4 cm/sec	29 cm/sec	0.78
ICA	98.8 cm/sec	46.8 cm/sec	0.53	ICA	79.5 cm/sec	29.7 cm/sec	0.63
ECA	66.8 cm/sec	11.1 cm/sec	0.83	ECA	68.3 cm/sec	9.7 cm/sec	0.86
VA	60.3 cm/sec	27.3 cm/sec	0.55	VA	55.5 cm/sec	24.5 cm/sec	0.56

Right

CCA Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal

Left

CCA Normal

ICA Normal

ECA Normal

VA Normal

Flow Volume RVA 158 + LVA 73 = 231

Result: Normal

Conclusion:

The results of the duplex study were within normal limits. The total VA flow amount was adequate.

Checker: 鍾季廷醫師

超音波影像



恩主公醫院

成人心臟超音波檢查報告

病患姓名:

性別: F

檢查日期: 20250325

病歷號碼:

病患來源:

檢查時間: 104318

年齡: 40

病床號碼:

編號: PEH05143246002

[M-mode]

	測量值	單位
IVSd	0.91	cm
LVIDd	4.12	cm
LVPWd	0.95	cm
LVIDs	2.33	cm
Ao root diam	2.26	cm
LA dimension	3.65	cm
LA/AO	1.61	
EF(Teich)	75	%
EPSS		cm
AVE	1.53	

[Ao flow]

	測量值	單位
Ao V max		cm / s
Ao max PG		mmHg

[Mitral flow]

	測量值	單位
MV E point	93.4	cm / s
MV A point	61.7	cm / s
MV E/A	1.51	
MV max PG	3.5	mmHg

[PA flow]

	測量值	單位
PA V max		cm / s
PA max PG		mmHg

[Tricuspid flow]

	測量值	單位
Max vel(TR)	232.7	cm / s
Max PG(TR)	21.7	mmHg

[Conclusion]

Normal LA and LV size / Normal LV wall thickness
 Normal LV systolic function, LVEF: 75 % / Normal LV wall motion
 Mild TR, Mild PR

Checker: 李宜澤醫師

超音波影像



恩主公醫院

Shear wave 肝纖維化及脂肪肝掃描

病患姓名:	性別: F	檢查日期: 20250325
病歷號碼:	病患來源:	檢查時間: 090049
年齡: 40	病床號碼:	編號: PEH16143246003

肝硬度數值 (Liver Stiffness) SWM (shear wave measurement) = 0.97

參考範圍:

纖維化等級	SWM Cut-off 值 (m/s)
正常 (F0)	≤ 1.19
輕度 (F1)	1.30
中度 (F2)	1.47
重度 (F3)	1.81
肝硬化 (F4)	≥ 2.00

註: SWM 為多次掃描後數值的平均值, 因為非侵入性檢查, 其診斷率會受部份因素影響 (如脂肪肝、呼吸配合度、是否曾開刀、腸氣多寡...等), 判讀結果僅供臨床醫師參考, 最終仍需配合臨床醫師判斷是否需要其他輔助性檢查 (如血液檢查、病理切片、影像檢查)。

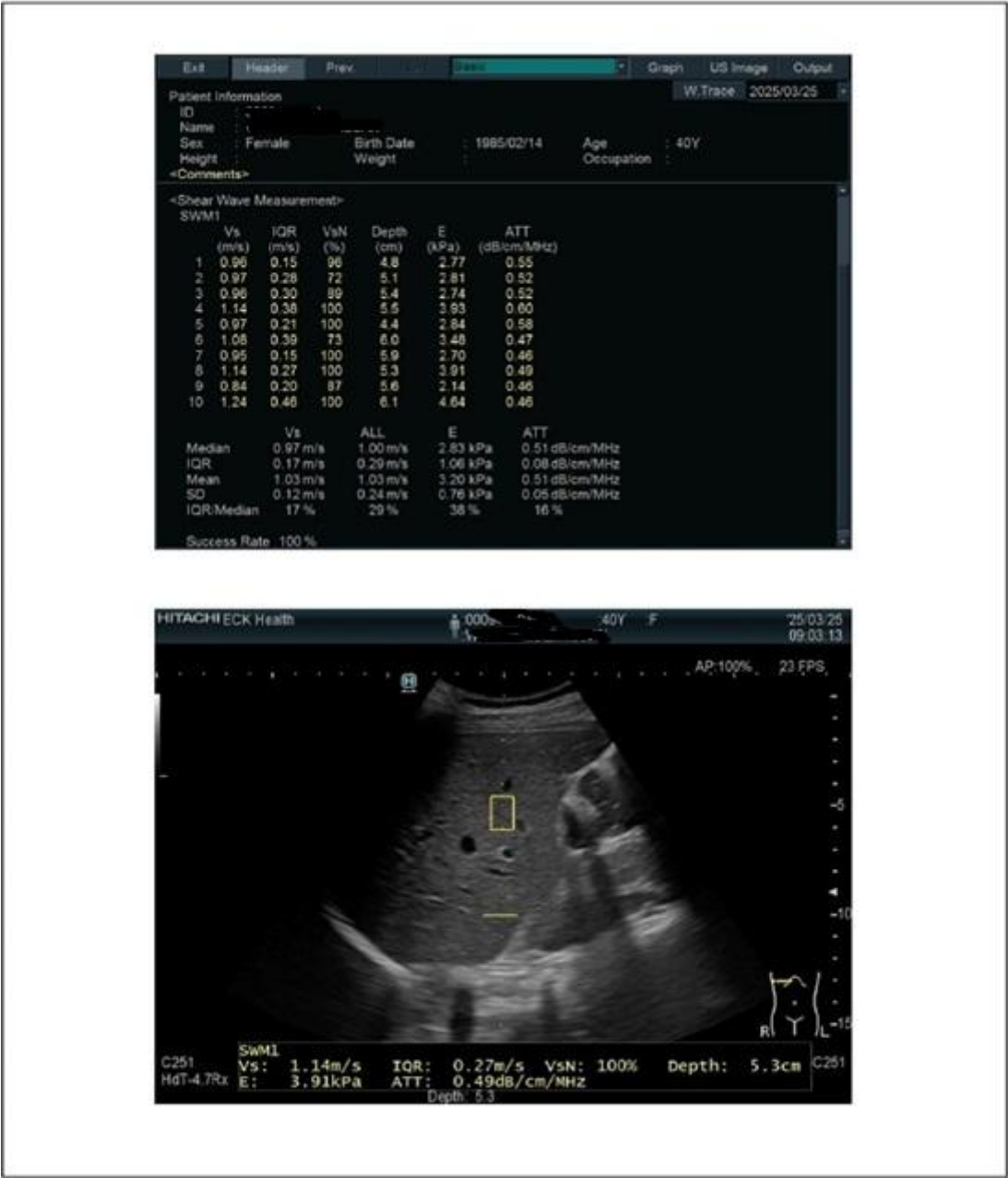
脂肪肝數值 ATT (attenuation coefficient) = 0.51

參考範圍:

脂肪肝等級	ATT 值 (dB/cm/MHZ)
正常 (S0)	≤ 0.61
輕度 (S1)	0.62-0.66
中度 (S2)	0.67-0.72
重度 (S3)	≥ 0.73

註: 若受檢者的皮下脂肪太厚, 有可能影響數值準確度。若 ATT 數值跟實際影像狀況有落差時, 應由醫師評估實際超音波狀況, 來判定脂肪肝程度。

超音波影像



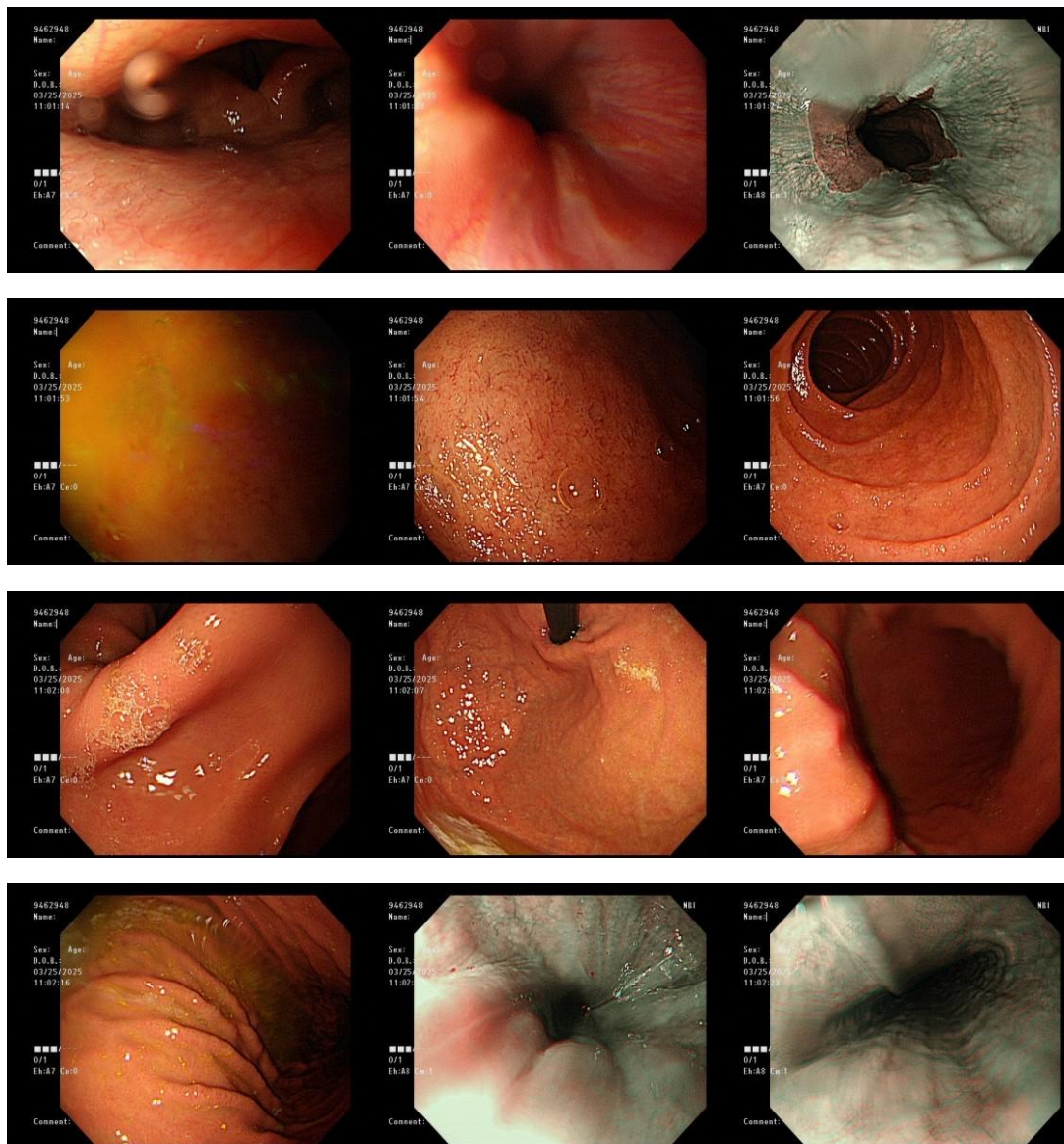
精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

胃鏡

報告

診斷（**Diagnosis**） 輕度至中度逆流性食道炎(LA class B)

內視鏡影像



內視鏡影像

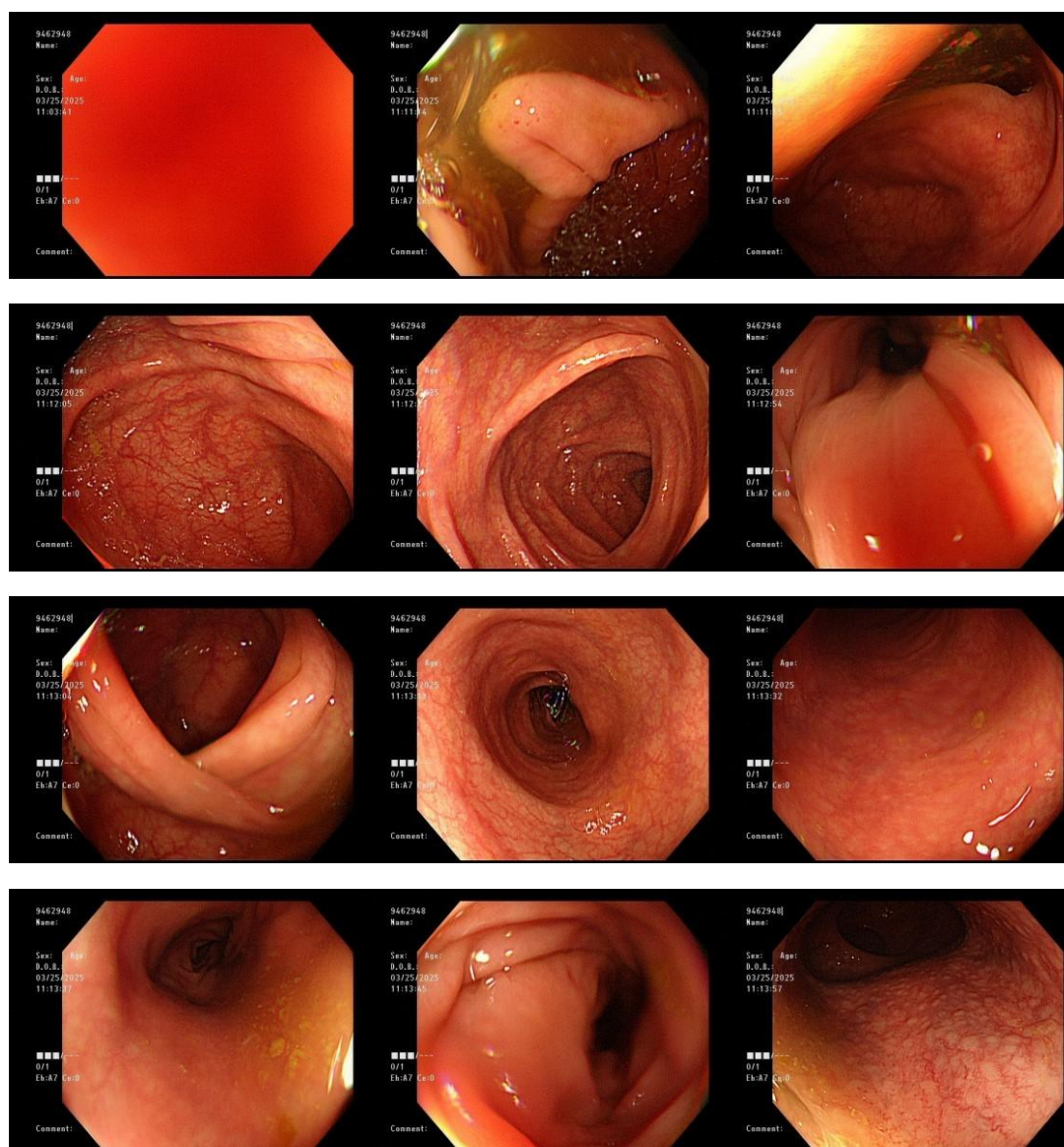


精密儀器檢查（Precision instrument inspection）

大腸鏡

報告
診斷（Diagnosis） 無明顯異常

內視鏡影像



內視鏡影像



精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

鼻咽喉內視鏡

報告
診斷 (Diagnosis) 兩側鼻中 膈彎曲慢性肥厚性鼻炎急性 咽喉炎

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

胸部 X 光檢查

報告
診斷 (Diagnosis) 無明顯異常 報告全部 (Total) Chest PA shows: > No abnormal lung opacity. > The heart size is within normal limit. > No significant abnormality of the mediastinum, trachea, main bronchi, diaphragm, pleura, and bony thoracic cage.

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

低劑量肺部電腦斷層

報告

診斷 (Diagnosis) 無明顯異常

報告全部 (Total)

Low dose CT showed :

heart and aorta: no obvious abnormality.

lung: no obvious abnormality. mediastinum: no obvious abnormality. bronchus: no obvious abnormality. pleura: no obvious abnormality.

bone: no obvious abnormality. visible upper

abdomen: no obvious abnormality.

(預估此次有效輻射劑量為 0.32mSv)

電腦斷層影像



各科檢查(Inspection) 中醫

十二經絡

診斷 (Diagnosis)

1. 平均體能：體能低落
2. 新陳代謝：新陳代謝功能減低
3. 筋骨血氣：肌肉骨骼系統運作失調
4. 自律神經：異常

養生建議 (Suggestion)

1. 自律神經及膽經：(1)調整生活作息、放鬆心情，若有持續性不適時，應就醫遵從醫師用藥(2)日常生活維持適度運動、均衡營養、尋求抒解情緒管道，保持愉悅心情。
2. 腸胃日常保健食物：(1)建議飲食：米、玉米、高麗菜、蓮子、橘子、蜂蜜(2)注意消化道相關問題，建議三餐定時定量勿偏嗜，避免飲酒(3)胃酸問題勿空腹喝咖啡及茶，乾溼分離，減少甜食攝取。
3. 膀胱經腎經證候：(1)建議飲食：山藥、桑椹、黑豆、豆腐、芹菜、木耳等(2)建議可拉筋伸展運動，也可參考八段錦第八式：雙手攀足固腎腰動作，若運動傷害處可熱敷或尋求中藥及針灸幫助。

佛萊明罕 (Framingham Risk Score) 危險預估評估表

佛萊明罕 (Framingham Risk Score) 危險預估分數對照表

年齡	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
女	-9	-4	0	3	6	7	8	8	8
男	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

膽固醇(mg/dl)	<160	160-199	200-239	240-279	≥280
女	-2	0	1	1	3
男	-3	0	1	2	3

高密度膽固醇(mg/dl)	<35	35-44	45-49	50-59	≥60
女	5	2	1	0	-3
男	2	1	0	0	-2

血壓(mmHg)	<120/80	120-129/80-84	130-139/85-89	140-159/90-99	≥160/100
女	-3	0	0	2	3
男	0	0	1	2	3

糖尿病	無	有
女	0	4
男	0	2

吸菸	無	有
女	0	2
男	0	2

預

估十年內發生冠心病的風險指數

您的分數	
年齡	0 分
膽固醇	0 分
高密度膽固醇	0 分
血壓	-3 分
糖尿病	0 分
吸菸	0 分
總分	-3 分
冠心病發生的機率為	1 %
醫師總評:	
您的心血管疾病十年風險屬於低度範圍。	